



TRAITEMENT DE LA DOULEUR EN CANCÉROLOGIE

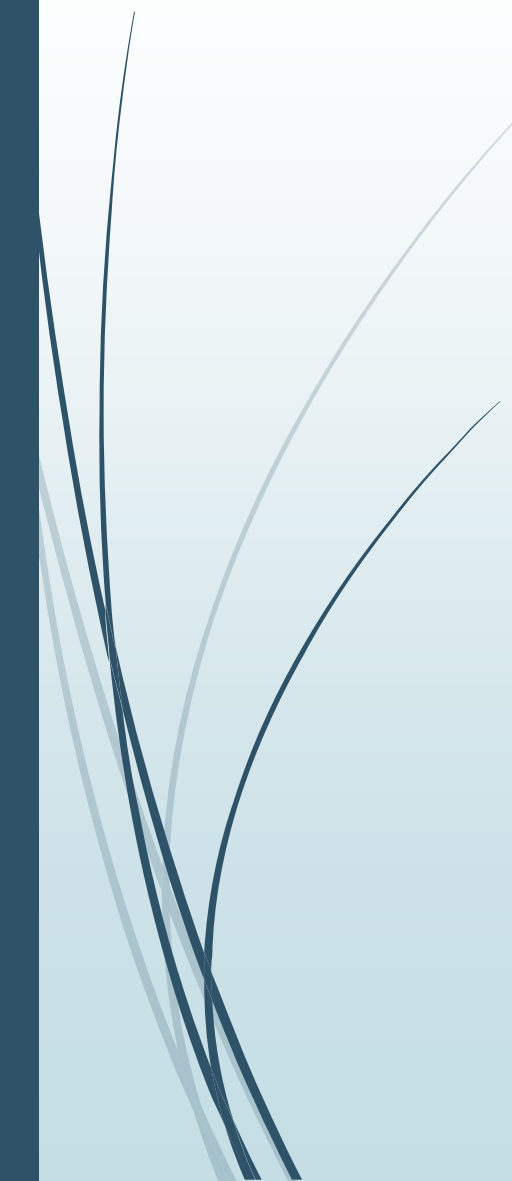
Dr BRAHMIA. A

Pr BENSALÉM.A

Oncologie médicale



Plan du cours:

- I. Définition
 - II. Type de la douleur
 - III. Mécanisme de la douleur
 - IV. Etiologies de la douleur
 - V. diagnostic et évaluation de la douleur
 - VI. Traitement de la douleur
 - VII. Conclusion
- 



Objectifs:

- Connaître les types de la douleur et leurs mécanismes en cancérologie
- Savoir évaluer la douleur
- Connaître l'arsenal thérapeutique antalgique



I. Définition:

- Selon IASP la douleur se définit comme:
- Une expérience **sensorielle** et **émotionnelle** désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en terme d'une telle lésion



II. Intérêt de la question:

- C'est le symptôme **le plus fréquent** chez le patient cancéreux
- L'importance de son retentissement psychologique, affectif et social
- Prise en charge individuelle pour chaque malade
- Au cours d'une maladie cancéreuse, l'apparition d'une douleur est une inquiétude tant pour le malade que pour le médecin: récurrence, échec au trt, évolution de la maladie



III. Types de la douleur:

➤ **Douleur aigue:**

- Symptôme d'apparition brutale
- Persiste plusieurs heures à plusieurs jours
- Cède par l'administration des antalgiques
- Douleur révélatrice (cancer colique, ostéosarcome,.....)

➤ **Douleur chronique:**

- Syndrome douloureux chronique (+ de 3 mois)
- Retentissement physique et psychique
- Représenté dans 60-90% des patients cancéreux

IV. Mécanisme de la douleur:

3 mécanismes:

- **Nociceptif:** lésion tissulaire, stimulation des récepteurs spécifiques à la douleur (nocicepteurs), douleur de rythme mécanique ou inflammatoire **avec un examen neurologique normal**
- **Neuropathique:**
 - par atteinte du système nerveux périphérique ou central (retentissement psychologique)
 - Douleur continue à type de brûlure, douleur paroxystique à type de décharge électrique (plus le traitement est précoce, plus il est efficace)
 - Anomalie dans l'examen neurologique: hypo ou hyper-esthésie,
- **NB:** la douleur cancéreuse est souvent mixte (douleur chronique), un fond douloureux avec des accès paroxystiques
- **Psychogène:** très rare, en cas de psychose

L'anxiété et la dépression majorent la perception de la douleur

V. Etiologies de la douleur:

- 1/ liée à l'évolution tumorale: 70% des cas
 - Douleur par compression et infiltration nerveuse: compression médullaire, atteinte du plexus nerveux
 - Douleur viscérale: occlusion, trouble du transit
 - Douleur osseuse: métastases osseuses
 - Douleur liée à l'inflammation et à l'ulcération des muqueuses
- 2/ douleur en rapport avec les soins: 20% des cas
 - ❑ Post chirurgie, post radiothérapie: radiodermite, radio-ostéo-nécrose
 - ❑ Post chimiothérapie: mucite, extravasations, neuropathie périphérique
- 3/ douleur en rapport avec une affection intercurrente: 10% des cas
Arthrose, ostéoporose,

VI. Diagnostic et évaluation de la douleur:

➤ Diagnostic de la douleur:

Interrogatoire:

topographie, mode d'apparition, aspect temporel, retentissement, efficacité d'un traitement antérieur

Identifier le mécanisme de la douleur

Examen physique et neurologique soigneux

Prescrire des examens complémentaires : pour éliminer une urgence:
compression médullaire, occlusion,.....

VI. Diagnostic et évaluation de la douleur:

► Evaluation de la douleur:

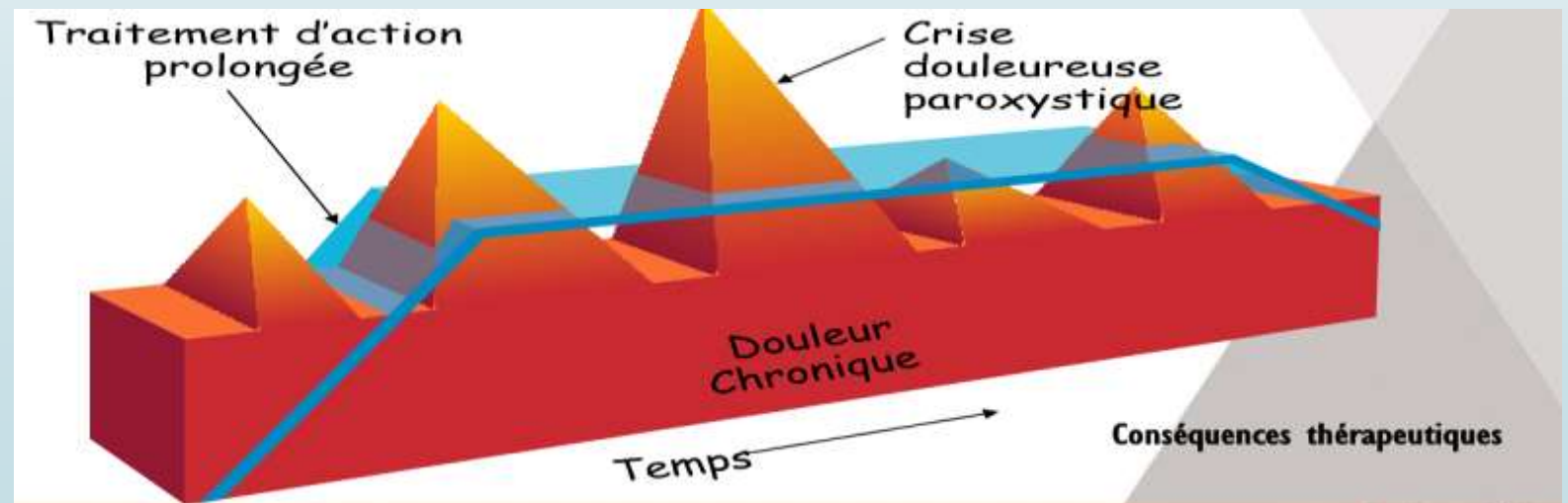
Importante ++++ , faite par l'équipe soignante et le patient

Rythme:

Intervalle régulier ,à chaque nouvelle épisode

Surveiller l'efficacité des antalgiques

Outils: unidimensionnelle et multidimensionnelle



VI. Diagnostic et évaluation de la douleur:

► **Échelle verbale simple ou E.V.S** : la plus utilisée

- ❖ Pas de douleur : 0.
- ❖ Faible : 1.
- ❖ Modérée : 2.
- ❖ Intense : 3.
- ❖ Extrêmement intense : 4.

► **Échelle verbale numérique ou E.V.N** :

- ❖ Note de **0 à 10**.
- ❖ Note 0: pas de douleur.
- ❖ Note 10: douleur maximale imaginable.

► **Échelle visuelle analogique ou E.V.A.**

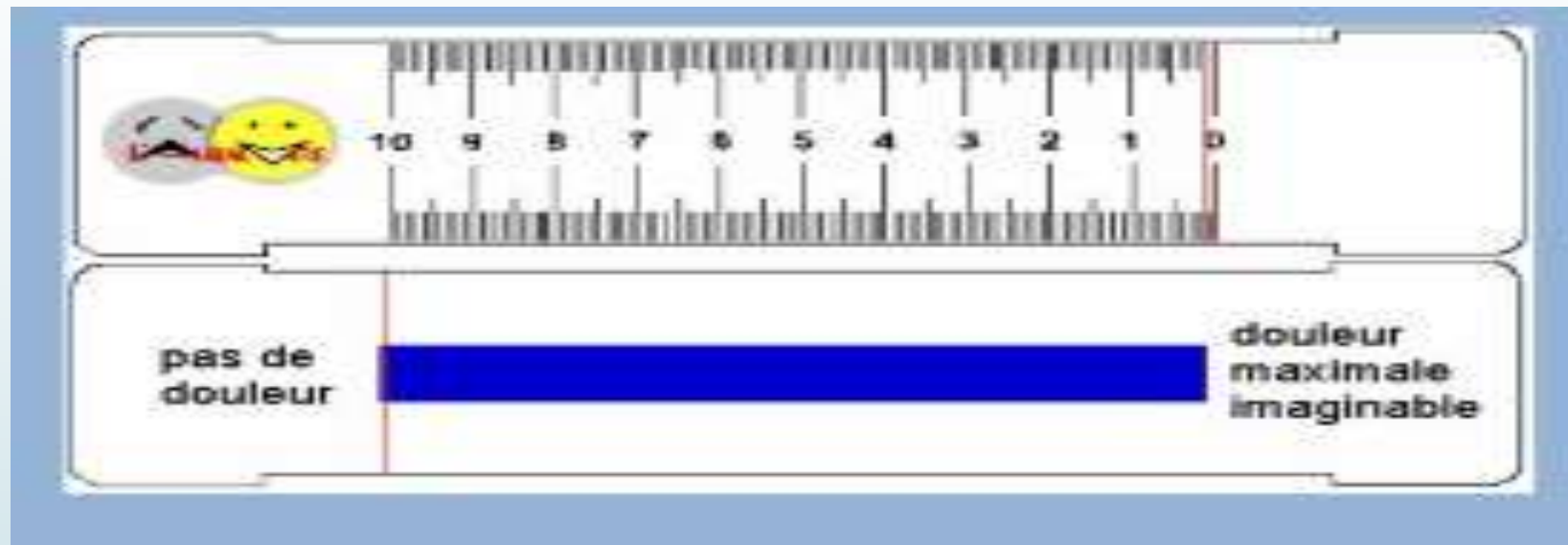
- ❖ Douleur faible : 0 à 4
- ❖ Douleur moyenne : 5 à 6
- ❖ Douleur forte : 7 à 10



VI. Diagnostic et évaluation de la douleur:

■ *Échelle multidimensionnelle*

- Modèles précis mais non simples.
- Questionnaires qualitatifs et quantitatifs validés.
- Adaptation à des situations particulières.
- Evaluation du soulagement et des autres composantes de la douleur (affectif, émotionnel,).
- Échelle **DN4** pour évaluer une douleur neuropathique.



Répondez aux 4 questions ci-dessous en cochant une seule case pour chaque item.

INTERROGATOIRE DU PATIENT

Question 1: La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes?

- 1 - Brûlure
- 2 - Sensation de froid douloureux
- 3 - Décharges électriques

oui	non
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Question 2: La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants?

- 4 - Fourmillements
- 5 - Picotements
- 6 - Engourdissement
- 7 - Démangeaisons

oui	non
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

EXAMEN DU PATIENT

Question 3: La douleur est-elle localisée dans un territoire ou l'examen met en évidence?

- 8 - Hypoesthésie au tact
- 9 - Hypoesthésie à la piqure

oui	non
☐	☐
☐	☐

Question 4: La douleur est-elle provoquée ou augmentée par:

- 10 - Le frottement

oui	non
☐	☐



VII. Traitement de la douleur:

▀ Principes généraux:

- Identifier le type de la douleur
- Soulager vite, efficacement et durablement: avec respect des 3 paliers de l'OMS
- Si douleur intense, mettre d'emblée un palier II
- Contrôle de la douleur sur le nycthémère
- Traitement à horaire fixe sans attendre la plainte
- Réévaluation périodique et quotidienne
- Préférer la voie orale, sublinguale et intradermique
- Prévenir, détecter et traiter les effets secondaires



VII. Traitement de la douleur:

- **Traitement spécifique de la cause** (même en phase palliative):
 - ✓ Chimiothérapie
 - ✓ Radiothérapie: métastases osseuses, compression médullaire, métastases cérébrales
 - ✓ Hormonothérapie: cancer de la prostate
 - ✓ Chirurgie: levée de l'obstacle, laminectomie
 - ✓ Traitement anti-infectieux: un abcès, une collection,.....

VII. Traitement de la douleur:

► Traitement de la douleur nociceptive: 3 paliers de l'OMS

Palier I de l'OMS: essentiellement pour la douleur légère à modérée

Paracétamol:

- Analgésique de premier choix lors de douleurs faibles.
- Initialement 500 mg PO aux 4 à 6 heures jusqu'à 1g aux 6 h; dose maximale: 4 g/j.
- Peut être associé à un AINS et/ou un opioïde.
- Toxicité hépatique si dose > 4g/j.
- Risque chez les patients alcooliques, malnutris ou inducteurs CYT3A4.
- Risque de surdosage si médicaments combinant le paracétamol à un autre antalgique

VII. Traitement de la douleur:

- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
 - Antalgiques périphériques de 2 choix si douleurs faibles vue leurs effets secondaires;
 - Utiles dans les douleurs inflammatoires (abcès, métastases osseuses).
 - Changer d'AINS si antalgie ou tolérance insatisfaisante au premier. Ne pas associer 2
 - Ibuprofène préféré car toxicité gastrique moindre 200mg PO/6-8h; max 2400mg/j
 - Forme retard disponible pour plusieurs AINS.+/- paracétamol et/ou un opioïde.
 - Rôle des inhibiteurs sélectifs de la COX-2 dans les douleurs cancéreuses indéterminé.
 - Toxicité gastrique et rénale, inhibition de l'agrégation plaquettaire, rétention hydro sodée, réactions allergiques, obnubilation, delirium.
 - CI : gastrite ou UGD, insuffisance rénale modérée à sévère, asthme, chimiothérapies néphrotoxiques, traitement anticoagulant, corticostéroïdes ou lithium.

VII. Traitement de la douleur:

Palier II de l'OMS: douleur modérée à intense, réponse insuffisante au palier I

Opioides faibles

Dihydrocodéine: 60 mg , 1 cp/ 12 heures

Tramadol: 50 mg et LP 50, 100, 150 et 200 mg

- Ampoule injectable à 100 mg
- Dose maximale 400 mg/ jour
- Ces deux molécules existent en association avec le paracétamol

Buprénorphine: temgesic

- Analgésique considéré comme intermédiaire entre les opioïdes faibles et forts.
- Forme injectable: 0,3-0,6 mg / jour en sous cutané, forme sublinguale
- Utile dans l'insuffisance rénale

Effets secondaires: somnolence, vertiges, nausées et vomissement, constipation

VII. Traitement de la douleur:

Palier III de l'OMS: opioïdes forts, douleur intense d'emblée

La morphine, l'oxycodone, l'hydromorphone et le fentanyl

● **TABEAU 2** Antalgiques oraux de palier 3 à libération prolongée

sulfate de morphine	comprimés 10, 30, 60, 100, 200 mg	voie orale, 1 prise toutes les 12h	
sulfate de morphine	gélules (ouvrables) 10, 30, 60, 100, 200 mg	voie orale, 1 prise toutes les 12h	
oxycodone	comprimés 5, 10, 20, 40, 80 mg	voie orale, 1 prise toutes les 12h	2 fois plus puissant que la morphine orale
hydromorphone	comprimés 4, 8, 16, 24 mg	voie orale, 1 prise toutes les 12h	7,5 fois plus puissant que la morphine orale
fentanyl	patches cutanés 12, 25, 50, 75, 100 µg/h	voie transcutanée patch à changer tous les 3 jours	100 fois plus puissant que la morphine orale

VII. Traitement de la douleur:

● **TABLEAU 3** Antalgiques oraux de palier 3 à libération immédiate

Molécule	Forme galénique	Remarque
morphine orale	forme liquide	unidose (10, 30, 100 mg) gouttes (1 goutte = 1,25 mg)
	comprimé ou gélule	dosages : 10 ou 20 mg
oxycodone orale	comprimé et forme oro-dispersible	5, 10, 20 mg
fentanyl transmuqueux	bâtonnet	200, 400, 600, 800, 1200, 1600 µg
	comprimé sub-lingual	100, 200, 300, 400, 600, 800 µg
	comprimé gingival	
	film orodispersible	
	spray nasal	2 formulations disponibles

VII. Traitement de la douleur:

■ Les interdoses:

- repose sur les formes à libération immédiate, et correspondent en règles générale : 1/6^{eme} à 1/10^{eme} de la dose LP quotidienne
- Elles se prennent à horaire fixe (toute les 4 heures) ou à la demande

■ Les effets secondaires des antalgiques palier III:

- Non spécifiques, mais doivent toujours faire rechercher d'autres causes: hypercalcémie, HIC, méningite, syndrome subocclusif,
- Doivent être prévenus et/ou traités. Certain s'atténuent au cours du temps (tolérance) : nausées et vomissements, d'autres persistent : constipation.
- Pas d'évidence en faveur d'un meilleur profil pour un opioïde; variations individuelles
- Exclure une affection sous-jacente, l'effet d'autres médicaments et/ou interactions.
- Face à un effet secondaire, plusieurs stratégies : Réduction des doses + co-analgésique. Traitement symptomatique. Changement la voie. Rotation opioïde.

VII. Traitement de la douleur:

► **Constipation**

- 70 à 90% des patients. Dose dépendante.
- Aggravée par la prise orale d'opioïde.
- Systématiquement prévenue par laxatifs quotidiens: osmotique: **et/ou** stimulant

► **Nausées et vomissements**

- 30 à 60% des patients. Partiellement dose dépendants. Tolérance en 7 à 10 jours.
- Pas de traitement sauf si apparition: Métoclopramide ou halopéridol.
- Si échec, rotation opioïde ou trt par anti-5HT3.

► **Somnolence**

- 20 à 60%. Dose dépendant, surtout personne âgée. Tolérance en 3 à 5 jours.
- Si persistance et gênante : stop autres sédatifs, rotation opioïde +/- méthylphénidate.
- Rechercher un surdosage, IR ou anomalies métaboliques

VII. Traitement de la douleur:

➤ *Syndrome de neurotoxicité*

- Confusion aiguë, hallucination, sédation profonde, myoclonie, hyperalgésie, allodynie
- Rotation opioïde. Stop psychotropes, surtout antidépresseurs. Réhydratation. Etat confusion aiguë, halopéridol (Haldol®) 1mg /8-12 h

➤ *Rétention urinaire*

➤ *Dépression respiratoire*

➤ *Dépendance physique et addiction*

➤ *Sècheresse buccale*

➤ *Prurit*



VII. Traitement de la douleur:

- Rotation des opioïdes:

Changement d'un opioïde par un autre, elle se pratique en cas de diminution du ratio: bénéfice/risque

Elle est indiquée aussi en cas de survenue d'effets indésirables rebelles ou résistances aux opioïdes

- notion de titration:

Détermination en milieu hospitalier (24-48h) de la dose minimale efficace destinée à neutraliser la douleur de fond

Ex: 60 mg de morphine: «30 mg matin et 30 mg soir

Interdose: 1/6 à 1/10 de la dose LP à horaire fixe/ 4 heures ou à la demande



VII. Traitement de la douleur:

► Co-antalgiques:

- ☐ Corticoïdes: à viser antalgique décompressive et anti-inflammatoire (HIC, compression médullaire, carcinose)
- ☐ Anxiolytiques: traiter les effets indirects de la douleur
- ☐ Anti-spasmodique

VII. Traitement de la douleur:

► Traitement de la douleur des métastases osseuses:

- Médicaments à visée osseuses
 - Biphosphonates
 - Denosumab
 - Effet antalgique, ne remplacent pas les analgésiques
- Radiothérapie externe
- Radiothérapie métabolique
 - Samarium
 - Radium 223
- Radiologie interventionnelle
 - Cimentoplastie
- Chirurgie
- Traitements antalgiques

VII. Traitement de la douleur:

► Traitement de la douleur neuropathique:

- **Traitement local:**
 - Patch de Lidocaine
 - Patch de Capsaïcine (centre spécialisé): neuropathies post-chimiothérapie
- **Anti-épileptiques:**
 - Gabapentine: gélules, comprimés: 3 prises/j, 300-2400 mg;
 - AMM douleurs post-zona
 - Prégabaline: gélules 25,50,75,100,150,200,300
- **Anti-dépresseurs:**
 - Amitriptyline :
 - 10 (voire moins) à 25 mg
 - paliers de 10 à 25 mg / 1 à 3 j, jusqu' à 50 à 75 mg/j
 - 1 prise au coucher (dose max 150 mg/j)
 - autres tricycliques
 - Place des inhibiteurs mixtes (recapture sérotonine et NA)
 - Duloxetine

VII. Traitement de la douleur:

► Cas particuliers:

- ❖ Sujet âgé: pas de contre indication mais la prudence est recommandée

En pratique: dose de départ / 2, prévention des effets secondaires

- ❖ **Insuffisance rénale:** principale limitation de la morphine
- ❖ **Insuffisance hépatique:** limite de l'utilisation du fentanyl

Toxicité des médicaments associés



VIII. Conclusion:

- Pour chaque patient, traiter la douleur de façon optimale c'est:
- Faire un diagnostic quantitatif, qualitatif, et étiologique de la douleur
- Assurer une prise en charge globale
- Tenir compte du terrain
- Connaitre l'arsenal thérapeutique et les différents médicaments
- Le traitement de la douleur fait partie de la prise en charge de la maladie au même titre que le traitement spécifique